

# 1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

Las emergencias y desastres, sean naturales, tecnológicas o biológicas, **exceden las capacidades del sector salud** y requieren la acción coordinada de **múltiples sectores del Estado y la sociedad civil**.

La **coordinación intersectorial** es el eje que permite una respuesta eficiente, evitando duplicaciones, mejorando el uso de recursos y garantizando una atención oportuna y equitativa.

En Chile, este principio se articula a través del **Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED)**, creado por la **Ley N° 21.364 (2021)**, que reemplazó a la antigua ONEMI y define la participación activa del **MINSAL, SEREMI, SENAPRED**, municipios, servicios públicos, FF.AA. y organizaciones civiles.

Para el médico general, especialmente en Atención Primaria (APS), comprender esta red es fundamental: su rol no se limita al diagnóstico clínico, sino que incluye **liderar la coordinación sanitaria local, educar a la comunidad y garantizar la continuidad asistencial durante emergencias**.

En el **EUNACOM**, este tema busca evaluar la comprensión del sistema sanitario como **parte integral del sistema de protección civil**, con énfasis en la gestión territorial, el trabajo en red y la comunicación interinstitucional.

---

## 2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

### 2.1. Coordinación intersectorial

Es el **proceso de planificación, comunicación y acción conjunta** entre instituciones públicas, privadas y comunitarias para reducir el riesgo y responder ante emergencias que amenazan la salud de la población.

**Objetivos principales:**

- Integrar esfuerzos y recursos disponibles.
- Alinear estrategias entre niveles y sectores.

- Garantizar coherencia en la comunicación y toma de decisiones.
  - Favorecer la resiliencia social e institucional.
- 

## 2.2. Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED)

Creado por la **Ley N° 21.364 (2021)**, el SINAPRED coordina las acciones de todos los sectores del Estado frente a emergencias.

Su órgano ejecutor es el **Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED)**, dependiente del Ministerio del Interior.

### Componentes principales:

1. **Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (CNGRED).**
  2. **Comités Regionales (COE-Regional)**, presididos por el Delegado Presidencial Regional.
  3. **Comités Comunales (COE-Comunal)**, coordinados por alcaldes.
  4. **Servicios Públicos Sectoriales**, incluyendo MINSAL, Educación, Obras Públicas, Interior, Defensa, etc.
  5. **Sociedad civil y voluntariado organizado.**
- 

## 2.3. Enfoque del Marco de Sendai (OPS/OMS, 2015–2030)

El **Marco de Sendai** orienta las políticas internacionales de reducción del riesgo de desastres, basándose en cuatro prioridades:

1. Comprender el riesgo de desastres.
2. Fortalecer la gobernanza del riesgo.
3. Invertir en resiliencia.
4. Mejorar la preparación y la “reconstrucción mejor” (*Build Back Better*).

La coordinación intersectorial es la **clave transversal** para alcanzar estos objetivos.

---

### 3. Estructura de coordinación en Chile

#### 3.1. Niveles de acción

| Nivel           | Entidad responsable                           | Rol principal                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nacional        | MINSAL, SENAPRED, Subsecretarías, Ministerios | Coordinación estratégica, comunicación oficial, gestión de recursos nacionales e internacionales. |
| Regional        | SEREMI de Salud, COE Regional                 | Implementar políticas y coordinar con Servicios de Salud y municipios.                            |
| Comunal / Local | Alcaldes, COE Comunal, APS                    | Ejecución operativa, educación, contención y asistencia directa.                                  |

---

#### 3.2. Actores clave del sector salud

| Actor              | Función principal                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| MINSAL             | Lidera la respuesta sanitaria, define lineamientos y comunica al nivel central. |
| SEREMI de Salud    | Coordina vigilancia, control ambiental y comunicación de riesgo.                |
| Servicios de Salud | Aseguran continuidad asistencial y gestión hospitalaria.                        |
| Centros de APS     | Pesquisa, educación, apoyo comunitario y contención psicosocial.                |

**ISP (Instituto de Salud Pública)**

Diagnóstico confirmatorio, bioseguridad y referencia.

**DEIS / EPIVIGILA**

Vigilancia epidemiológica y notificación nacional.

---

## 4. Mecanismos de coordinación intersectorial

### 4.1. Comité de Operaciones de Emergencia (COE)

Es el **espacio técnico-político de coordinación** donde se analizan las condiciones del evento y se definen acciones conjuntas.

Existen COE a nivel **nacional, regional y comunal**, y en el ámbito sanitario, **los COE de Salud** (en cada Servicio de Salud y hospital) operan con protocolos propios.

**Integrantes habituales:**

- MINSAL y SEREMI de Salud.
- SENAPRED.
- Carabineros, Bomberos, Defensa, SAMU.
- Municipalidades.
- Educación, Obras Públicas, Medio Ambiente.
- Organizaciones civiles, Cruz Roja, ONG.

---

### 4.2. Coordinación entre niveles asistenciales

Durante una emergencia sanitaria, la coordinación entre APS, hospitales y nivel central es fundamental:

1. **APS:** detección temprana, educación, derivación y seguimiento.
2. **Hospitales:** atención de casos graves y continuidad de servicios críticos.

3. **Servicios de Salud:** distribución de recursos, traslado de pacientes, comunicación con MINSAL.

El **flujo de información bidireccional** (de terreno al nivel central y viceversa) es esencial para una gestión efectiva.

---

#### 4.3. Coordinación con otros sectores

| Sector              | Contribución en la emergencia sanitaria                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Interior / SENAPRED | Coordinación general y gestión logística.                  |
| Defensa / FF.AA.    | Transporte, rescate, instalación de hospitales de campaña. |
| Educación           | Implementación de albergues y campañas educativas.         |
| Obras Públicas      | Restablecimiento de infraestructura y conectividad.        |
| Medio Ambiente      | Control ambiental y monitoreo de contaminantes.            |
| Municipios          | Distribución de ayuda, atención comunitaria y albergues.   |
| ONG y Cruz Roja     | Apoyo humanitario y psicosocial.                           |

---

### 5. Comunicación interinstitucional y de riesgo

Una de las principales funciones intersectoriales es la **comunicación de riesgo**: informar a la población de manera **transparente, oportuna y coordinada**.

**Principios OMS (2020):**

- Mensaje único y coherente entre autoridades.
- Evitar contradicciones públicas.
- Promover confianza y participación ciudadana.
- Adaptar el lenguaje al nivel local y cultural.

#### Ejemplo chileno:

Durante la pandemia COVID-19, la coordinación entre **MINSAL, municipios y medios locales** fue crucial para comunicar medidas preventivas y campañas de vacunación.

## 6. Herramientas operativas de coordinación

| Herramienta                                                          | Descripción                                       | Institución líder       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Plan Nacional de Emergencias y Desastres en Salud (2022–2030)</b> | Define roles y protocolos del sistema sanitario.  | MINSAL                  |
| <b>Protocolos de Coordinación Intersectorial SENAPRED</b>            | Manual de actuación entre ministerios.            | Ministerio del Interior |
| <b>EPIVIGILA</b>                                                     | Notificación y vigilancia epidemiológica.         | MINSAL                  |
| <b>SITREP / CENCOE</b>                                               | Reportes situacionales diarios.                   | SENAPRED y MINSAL       |
| <b>Planes comunales de emergencia sanitaria</b>                      | Estrategias locales para continuidad asistencial. | Municipios y APS        |

## 7. Rol del médico general en la coordinación intersectorial

| Función                            | Ejemplo                                             | Competencia EUNACOM                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Liderazgo local sanitario          | Participar en el COE comunal, coordinar equipo APS. | Gestión y comunicación en crisis.       |
| Vigilancia epidemiológica activa   | Notificar brotes, reportar casos al EPIVIGILA.      | Análisis de información epidemiológica. |
| Educación comunitaria              | Charla en albergues o escuelas.                     | Promoción y prevención.                 |
| Gestión de continuidad asistencial | Garantizar controles crónicos en catástrofes.       | Organización del trabajo clínico.       |
| Apoyo psicosocial                  | Contención y derivación postevento.                 | Competencia biopsicosocial.             |

---

## 8. Ejemplo práctico: terremoto y tsunami (Chile, 2010)

### Situación:

El terremoto del 27F (8,8 Mw) afectó 6 regiones. Se interrumpieron servicios de agua, electricidad y atención sanitaria.

### Respuesta intersectorial:

- **MINSAL y FF.AA.** instalaron hospitales de campaña.
- **Municipios** habilitaron albergues.
- **Educación** transformó escuelas en centros de atención.
- **ONG y Cruz Roja** brindaron apoyo logístico y emocional.

- **SENAPRED (ex ONEMI)** coordinó la distribución de ayuda.

#### Lección:

El éxito radicó en la **coordinación transversal**, más que en la cantidad de recursos.

---

## 9. Errores comunes en EUNACOM

| Error frecuente                                                     | Corrección conceptual                                              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Pensar que la respuesta sanitaria es autónoma del resto del Estado. | Es <b>parte del SINAPRED</b> , bajo coordinación del SENAPRED.     |
| Confundir comunicación de riesgo con vocería política.              | Es una <b>herramienta sanitaria</b> , no política.                 |
| Subestimar el rol de APS.                                           | La APS lidera vigilancia, educación y contención local.            |
| Ignorar participación municipal.                                    | Los municipios son actores esenciales en la logística y albergues. |
| No incluir ONG y sociedad civil.                                    | Son parte legítima y formal del sistema de respuesta.              |

---

## 10. Desafíos actuales

1. **Fragmentación institucional:** múltiples actores con escasa interoperabilidad digital.
2. **Falta de simulacros reales y actualización de planes locales.**
3. **Débil comunicación entre niveles asistenciales.**



4. **Desigualdad territorial en capacidades de respuesta.**
5. **Cambio climático y nuevas amenazas biológicas.**

**Enfoque futuro:** fortalecer una gobernanza sanitaria intersectorial basada en **resiliencia, equidad y digitalización**.

---

## 11. Referencias ministeriales y técnicas

- **Ley N° 21.364 (2021).** Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED).
  - **MINSAL (2022).** Plan Nacional de Emergencias y Desastres en Salud 2022–2030.
  - **SENAPRED (2023).** Manual Operativo de Coordinación Intersectorial.
  - **OPS/OMS (2015–2030).** Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres.
  - **MINSAL (2021).** Manual de Organización del COE-Salud.
- 

## 12. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. La **coordinación intersectorial** es esencial para una respuesta eficaz ante emergencias sanitarias.
2. En Chile, el **SINAPRED** y su brazo operativo, **SENAPRED**, articulan a todas las instituciones públicas y privadas.
3. El **MINSAL**, a través de SEREMI y Servicios de Salud, lidera la gestión sanitaria del riesgo.
4. La **APS y los municipios** cumplen un rol estratégico en vigilancia, educación y apoyo comunitario.
5. El **COE (Comité Operativo de Emergencia)** es la estructura operativa central de coordinación.
6. La **comunicación de riesgo** y la **transparencia informativa** son fundamentales para mantener la confianza ciudadana.

7. En el EUNACOM, este tema integra gestión, liderazgo, bioética y salud pública aplicada.